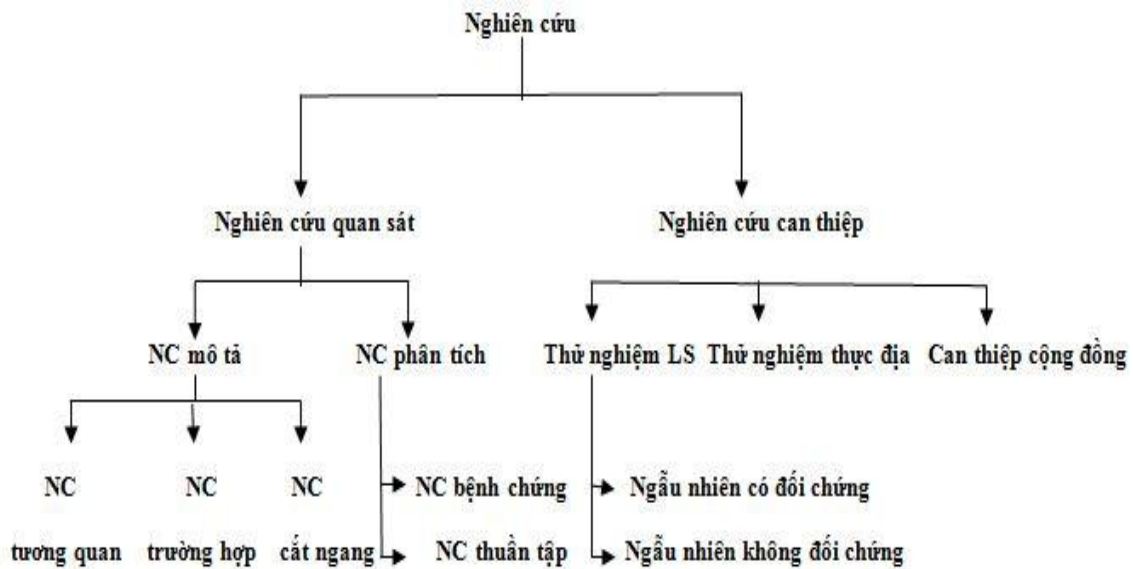


ĐỀ CƯƠNG TỐT NGHIỆP DỊCH TỄ HỌC 2018

Câu 1: Các chiến lược thiết kế dịch tễ học:.....	2
Câu 2: Trình bày định nghĩa, ưu nhược điểm của từng phương pháp NC mô tả (NC tương quan, điều tra ngang).....	3
Câu 3: Định nghĩa, vẽ sơ đồ, ưu ,nhược điểm của NC bệnh chứng:	4
Câu 4.Trình bày định nghĩa, ưu nhược điểm của phương pháp NC thuần tập:	5
Câu 5: Định nghĩa, mục tiêu, tiêu chuẩn của 1 chương trình khám sàng tuyển:	6
Câu 6: Tỷ suất hiện mắc: ĐN, các loại tỷ suất hiện mắc, ứng dụng và mối liên quan giữa tỷ suất hiện mắc và tỷ suất mới mắc	7
Câu 7: Định nghĩa, phân loại sai số hệ thống:	9
Câu 8: Cơ chế truyền nhiễm và phân loại bệnh truyền nhiễm:.....	11
Câu 9.Trình bày phương thức lây nhiễm chủ yếu và biện pháp dự phòng HIV/AIDS	13
Câu 10: Trình bày các yêu cầu và các giai đoạn tiến hành điều tra một vụ dịch.....	14
Câu 11: Các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết.....	15
Câu 12: Trình bày các biện pháp phòng chống bệnh tả.....	16
Câu 13: Trình bày biện pháp phòng chống bệnh cúm mùa:	17
Câu 14: Các loại vacxin và lịch tiêm chủng trong chương trình lịch tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam: bản chất, liều tiêm, đường dùng, bảo quản và lịch tiêm của từng loại.....	18
Câu 15: Các biện pháp dự phòng bệnh tim mạch:	20
Câu 17: Trình bày ĐNNC can thiệp, NC thực nghiệm và NC phỏng thực nghiệm và vẽ sơ đồ từng loại thiết kế NC:.....	23
Câu 18:Trình bày biện pháp y tế nhằm phòng chống các bệnh truyền nhiễm đối với nguồn truyền nhiễm	25
Câu 19.Trình bày các biện pháp y tế nhằm phòng chống các bệnh truyền nhiễm đối với đường truyền nhiễm	27
Câu 20. Trình bày định nghĩa, mục tiêu và ứng dụng của giám sát dịch tễ học:.....	29

Câu 1: Các chiến lược thiết kế dịch tễ học:

*Sơ đồ các thiết kế NC(NC):



* Trong NC quan sát, nhà NC chỉ mô tả, phân tích tình hình nhưng không can thiệp. Trong khi NC can thiệp là một NC thực nghiệm có kế hoạch trong đó tình trạng PN của các đối tượng NC là do người NC chỉ định

* Trong nhóm NC quan sát, NC mô tả bao gồm việc thu thập và trình bày có hệ thống các số liệu nhằm cung cấp một bức tranh về một tình huống cụ thể và hình thành giả thuyết căn nguyên cho các NC phân tích. Trong khi NC phân tích nhằm kiểm định giả thuyết, xác định mối quan hệ giữa PN và kết quả NC

* Trong NC can thiệp:

- Thử nghiệm lâm sàng và thử nghiệm thực địa nhằm đánh giá hiệu lực của thuốc trên bệnh nhân lâm sàng hay của các giải pháp can thiệp trên cộng đồng. Đòi hỏi thiết kế chặt chẽ tuân thủ các yếu tố như ngẫu nhiên, làm mù...
- Can thiệp cộng đồng là sau khi các giải pháp can thiệp hay thuốc đã được đánh giá có hiệu lực thì triển khai đánh giá tính hiệu quả trong bối cảnh cộng đồng khi không có khả năng kiểm soát các yếu tố tối ưu như ngẫu nhiên hóa, , làm mù.

Câu 2: Trình bày định nghĩa, ưu nhược điểm của từng phương pháp NC mô tả (NC tương quan, điều tra ngang)

1.NC tương quan:

a.Định nghĩa: NC tương quan mô tả mối liên quan của bệnh với một yếu tố mà ta quan tâm như tuổi, thời gian, sự sử dụng các dịch vụ y tế, tiêu thụ thức ăn, thuốc hay các sản phẩm khác

b.Uu điểm:

- Là bước đầu tiên trong việc điều tra mối quan hệ giữa PN và bệnh
- Có thể được tiến hành nhanh, không tốn kém
- Thường sử dụng các thông tin có sẵn về nhân khẩu học, tiêu thụ sản phẩm, sử dụng các dịch vụ y tế và tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong

C. Nhược điểm:

- Không có khả năng nối liền PN với bệnh ở từng cá thể riêng biệt
- Thiếu khả năng kiểm soát ảnh hưởng của các yếu tố nhiễu
- Chỉ mô tả được mức PN trung bình của quần thể chứ không mô tả mức PN của từng cá thể. Trong khi đó có sự kết hợp tuyến tính âm tính hay dương tính tuyệt đối, nó có thể che dấu một quan hệ phức tạp hơn giữa PN và bệnh

2.Điều tra ngang:

a. Định nghĩa:

- Là 1 NC trong đó tình trạng bệnh và PN được đánh giá đồng thời ở 1 quần thể xác định tại 1 thời điểm
- Cung cấp “hình ảnh chụp nhanh” về diễn biến sức khỏe của dân chúng ở một thời điểm đặc biệt

b.Uu điểm:

- Những số liệu từ điều tra ngang rất có giá trị đối với các nhà lãnh đạo y tế công cộng trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe và các nhu cầu chăm sóc y tế của nhân dân
- Cung cấp thông tin về tỷ lệ mắc bệnh toàn bộ các bệnh cấp tính và mạn tính, tình trạng mất khả năng lao động, việc sử dụng các dịch vụ y tế, các đặc trưng về cá nhân và nhân khẩu học
- Điều tra ngang có thể được tiến hành dưới dạng 1 cuộc điều tra sức khỏe của quần thể, thông qua việc chọn mẫu ngẫu nhiên các cá thể từ 1 quần thể. Các đối tượng NC được hỏi theo bảng câu hỏi chuẩn mực và thống nhất về tình trạng sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng, các đặc trưng cá nhân, các điều kiện kinh tế xã hội và gia đình, các thói quen và lối sống, việc sử dụng các dịch vụ y tế... Các đối tượng NC cũng được khám về thể lực và xét nghiệm.

C. Nhược điểm:

Vì PN và tình trạng bệnh được đánh giá ở 1 thời điểm nên hạn chế của điều tra ngang là trong nhiều trường hợp, không thể xác định được bệnh xảy ra là do PN với chất độc hại quá nhiều hay PN chỉ là hậu quả của bệnh.

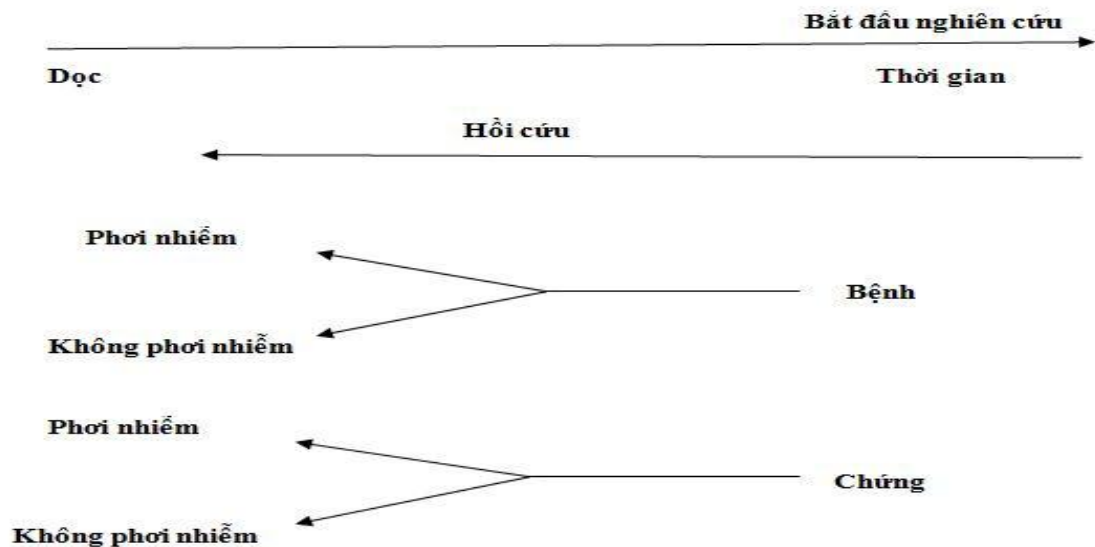
Ví dụ: Giả sử có 100 công nhân làm công việc A được biết là độc hại và 100 công nhân làm công việc B được biết là không độc hại. Nhưng tỷ lệ bệnh ở công nhân làm việc A thấp hơn việc B vì những người ốm bệnh đã chuyển sang việc B.

Câu 3: Định nghĩa, vẽ sơ đồ, ưu ,nhược điểm của NC bệnh chứng:

1. Định nghĩa:

- Là một NC dịch tễ học phân tích quan sát
- Trong đó các đối tượng NC được chọn trên cơ sở có bệnh hay không có bệnh nào đó mà ta NC
- Các nhóm này được so sánh với nhau về tiền sử PN với 1 yếu tố nguy cơ có thể là căn nguyên của bệnh

2.Sơ đồ NC bệnh chứng:



2. Ưu điểm

- Thực hiện tương đối nhanh
- Ít tốn kém hơn so với các NC phân tích khác
- Đặc biệt thích hợp với các bệnh có thời kỳ ủ bệnh kéo dài
- Tối ưu trong NC các bệnh hiếm vì các đối tượng NC được lựa chọn dựa trên cơ sở tình trạng bệnh
- Có khả năng điều tra ảnh hưởng của nhiều yếu tố căn nguyên
- Là bước khởi đầu cho việc xác định các yếu tố phòng bệnh hay nguyên nhân của 1 bệnh mà ta còn biết rất ít

3. Nhược điểm

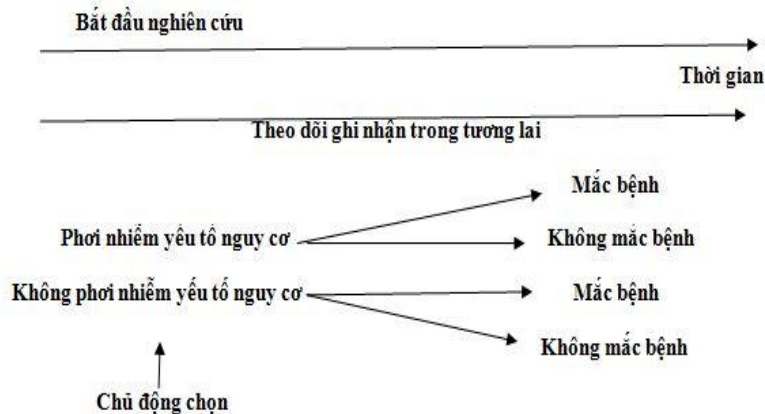
- Không có hiệu quả khi NC các PN hiếm trừ khi NC rất lớn hay PN phổ biến ở những người mắc bệnh
- Không thể tính toán trực tiếp tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm PN và nhóm không PN trừ khi NC dựa trên quần thể
- Trong nhiều trường hợp, mối quan hệ về mặt thời gian giữa PN và bệnh khó có thể xác định được.
- Nhạy cảm với các sai lệch, đặc biệt là sai số nh

Câu 4. Trình bày ĐN, ưu nhược điểm của phương pháp NC thuần tập:

a. Định nghĩa:

NC thuần tập hay còn gọi là NC theo dõi là một loại nghiên cứu quan sát, trong đó một hay nhiều nhóm cá thể được chọn trên cơ sở có PN hay không PN với yếu tố nguy cơ. Tại thời điểm NC, tình trạng PN được xác định, tất cả các đối tượng NC chưa mắc bệnh mà ta NC và được theo dõi trong một thời gian dài để đánh giá sự xuất hiện bệnh đó

b. Sơ đồ phương pháp NC thuần tập:



c. Ưu điểm của phương pháp NC thuần tập:

- NC thuần tập rất có giá trị và tối ưu khi NC ảnh hưởng của các PN hiếm gặp
- Cho phép người điều tra xác định được cỡ mẫu thích hợp ở nhóm PN và nhóm không PN vì các cá thể được lựa chọn vào NC dựa trên tình trạng PN của họ
- Bằng NC này, người ta có thể kiểm định ảnh hưởng nhiều mặt của một PN đến sự phát triển nhiều bệnh
- Có thể làm sáng tỏ mối quan hệ về thời gian giữa PN và bệnh vì tại thời điểm NC, các đối tượng NC chưa bị bệnh
- Cho phép tính toán trực tiếp tỷ lệ mới mắc bệnh ở cả hai nhóm có và không PN.

d. Nhược điểm:

- NC thuần tập không có hiệu quả khi đánh giá các bệnh hiếm gặp, trừ khi quần thể NC cực kỳ lớn, khi bệnh phổ biến ở những người có PN, tức là phần trăm nguy cơ quy thuộc cao
- Nếu là NC thuần tập tương lai, rất tốn kém về kinh phí và thời gian so với NC bệnh chứng hay NC thuần tập hồi cứu
- Nếu là NC thuần tập hồi cứu đòi hỏi phải có hồ sơ đầy đủ
- Giá trị kết quả NC có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất các đối tượng NC trong quá trình theo dõi

Câu 5: ĐN, mục tiêu, tiêu chuẩn của 1 chương trình khám sàng tuyển:

a. Định nghĩa:

Sàng tuyển là việc phát hiện sớm 1 bệnh chưa có biểu hiện rõ về lâm sàng bằng 1 xét nghiệm hay thăm khám từ đó phân loại rõ ràng ra những người hoàn toàn khỏe mạnh và những người có thể đã bị bệnh

b. Mục tiêu:

- Là một phần của điều tra dịch tễ học nhằm xác định tần số hay lịch sử tự nhiên của bệnh
- Phòng lây nhiễm hay phòng bệnh cho cộng đồng

c. Tiêu chuẩn một chương trình sàng tuyển:

- Bệnh sàng tuyển phải là một vấn đề sức khỏe quan trọng
- Bệnh sàng tuyển phải là bệnh có phương pháp điều trị có hiệu quả sau khi bệnh được chẩn đoán
- Có các điều kiện và phương tiện chẩn đoán và điều trị
- Bệnh sàng tuyển phải có thời kỳ yên lặng rõ ràng hay giai đoạn có triệu chứng sớm
- Bệnh sàng tuyển phải được cộng đồng chấp nhận
- Bệnh sàng tuyển phải có lịch sử tự nhiên của bệnh rõ ràng, từ khi bị bệnh chưa có triệu chứng đến khi có triệu chứng rõ ràng
- Phải có chủ trương và đường lối rõ ràng trong việc điều trị bệnh nhân sau khi được phát hiện
- Giá thành của việc phát hiện bệnh phải phù hợp với chi phí chăm sóc và điều trị toàn bộ
- Phân tích hiệu quả giá thành phải được tiến hành cân nhắc đến hiệu quả của việc phát hiện sớm (làm giảm tỷ lệ chết) so với các nguồn lực hiện có, các nguy cơ và sự bất tiện của sàng tuyển vào quy trình xét nghiệm chẩn đoán gây bất tiện hay khó chịu cho bệnh nhân
- Chẩn đoán phát hiện bệnh nhân phải là một quá trình liên tục chứ không phải chỉ được tiến hành 1 lần

Câu 6: Tỷ suất hiện mắc: ĐN, các loại tỷ suất hiện mắc, ứng dụng và mối liên quan giữa tỷ suất hiện mắc và tỷ suất mới mắc

1. Tỷ suất hiện mắc(P):

***Định nghĩa:** Tỷ suất này đo lường tần số hiện mắc của bệnh của 1 quần thể ở 1 điểm nhất định của thời gian hay ở 1 khoảng thời gian nhất định

$$P = \frac{\text{Tổng số bệnh nhân hiện mắc của một bệnh tại một thời điểm nhất định hay trong một khoảng thời gian nhất định}}{\text{Tổng số người ở quần thể có nguy cơ (k là bội số của 10 như 100,...)}} \times k$$

- *Ý nghĩa:**
- Đánh giá sức khỏe quần thể đối với một bệnh.
 - Lập dự án về nhu cầu chăm sóc SK cho quần thể.
 - Khai thác các quan hệ nhân quả.

2. Tỷ suất mới mắc:

***Định nghĩa:** Tỷ suất này đo lường tần số mới mắc bệnh của một quần thể trong một khoảng thời gian nào đó.

- Có 2 loại tỷ suất mới mắc:

+ Tỷ suất mới mắc tích lũy(CI):

$$CI = \frac{\text{Tổng số trường hợp mới mắc của một bệnh của Một quần thể trong một khoảng thời gian xác định}}{\text{Tổng số người có nguy cơ mắc bệnh của quần thể đó trong thời gian đó (k là bội số của 10 như 100,...)}} \times k$$

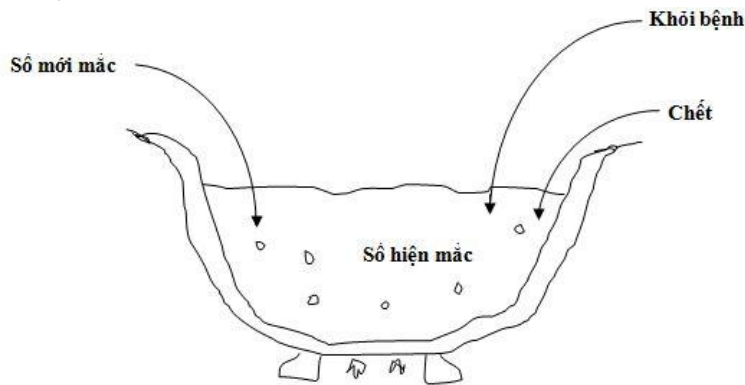
+ Tỷ suất mật độ mới mắc (ID):

$$ID = \frac{\text{Tổng số trường hợp mới mắc của của một bệnh ở một quần thể trong một khoảng thời gian xác định}}{\text{Tổng thời gian có nguy cơ theo dõi được của tất cả các cá thể (k là bội số của 10 như 100,...)}} \times k$$

*Ý nghĩa:

- Là một chỉ số quan trọng cho các nhu cầu phòng bệnh, rất có ích cho các bệnh cấp tính và cho cả các bệnh mạn tính.
- Cho phép đánh giá hiệu lực của các biện pháp y tế đã đáp ứng trong quần thể: nếu các biện pháp có hiệu lực(đối với từng cá thể và cả quần thể)thì tỷ lệ mới mắc sẽ giảm đi.
- Tỷ suất mới mắc còn có ích trong quá trình đánh giá một hiện tượng mắc hàng loạt khi đối chiếu đỉnh cao nhất của nguy cơ(xảy ra trong quá khứ)với đỉnh cao của tỷ lệ mới mắc, có thể biết được ước lượng của thời kỳ ủ bệnh.

3. Mối liên quan giữa tỷ suất hiện mắc và tỷ suất mới mắc: Nội tỷ lệ hiện mắc:



*Tỷ suất hiện mắc(P) phụ thuộc chủ yếu vào tỷ suất mới mắc (I) và thời gian mắc bệnh trung bình(D): $P = I \times D$

*Ta có mối liên quan:

-Nếu mà $P < 10\%$ thì có $P = I \times D$ (D là bệnh kỳ của bệnh)

-Nếu mà $P \geq 10\%$ thì có:

$$P = \frac{I \times D}{I + (I \times D)}$$

Câu 7: Định nghĩa, phân loại sai số hệ thống:

1. Định nghĩa sai số hệ thống: Là bất kỳ sai số nào trong quá trình NC làm sai lệch ước lượng sự kết hợp giữa PN và bệnh như cách chọn người vào NC, cách thu thập số liệu, ghi chép, tập hợp và phiên giải các thông tin đó

2. Phân loại sai số hệ thống:

2.1. Sai số chọn:

- Sai số chọn sẽ có thể nảy sinh khi việc xác định những cá thể là đối tượng NC vào trong nhóm các nhóm NC, dựa trên PN (NC thuần tập) hay dựa trên bệnh (NC bệnh chứng)
- Sai số chọn có tầm quan trọng đặc biệt trong các NC bệnh chứng và NC thuần tập hồi cứu vì ở loại NC này, cả hai sự kiện PN và bệnh đều đã xảy ra trước khi các cá thể được chọn vào NC

***Sai số chẩn đoán:**

Ví dụ: NC về sự kết hợp giữa dùng oestrogen ngoại sinh với bệnh với ung thư tử cung, đã cho thấy sự gia tăng giả tạo nguy cơ ung thư tử cung ở phụ nữ dùng oestrogen, vì các phụ nữ có dùng oestrogen thường bị nên thường đến bệnh viện khám và được chẩn đoán là ung thư cao hơn hẳn ở phụ nữ không dùng oestrogen

***Sai số từ chối hoặc sai số không trả lời:**

Ví dụ: Nếu nhóm đối chứng được chọn bằng cách đi điều tra ở các hộ gia đình, thì rất có thể có những người không trả lời, hoặc từ chối không trả lời. Điều đó sẽ liên quan đến các biến số về dân số, lối sống, nghề... mà một số hoặc tất cả biến số đó lại có thể chính là những yếu tố nguy cơ phát triển bệnh

2.2. Sai số quan sát: Sẽ xảy ra nếu có sự khác nhau một cách có hệ thống trong việc thu thập những thông tin về PN hoặc về bệnh từ hai nhóm trong NC

***Sai số nhớ lại:**

- Xảy ra khi các cá thể ở nhóm đã nhớ sai hoặc báo cáo tình trạng PN trước đây của họ khác với nhóm cá thể không bị bệnh đó
- Loại sai số này là vấn đề đặc biệt lớn trong các NC bệnh chứng và các NC thuần tập hồi cứu, vì cả hai sự kiện PN và bệnh đã xảy ra trước khi NC
- Sai số nhớ lại có thể làm khuếch đại hơn hoặc giảm hơn sự kết hợp giữa PN và bệnh tùy thuộc sự nhớ lại về tình trạng PN của nhóm bệnh là lớn hơn hay nhỏ hơn so với nhóm chứng

***Sai số thu thập thông tin hay sai số phỏng vấn:**

- Nó bao gồm bất cứ một sai khác hệ thống nào trong việc khai thác thu thập, ghi chép hoặc phiên giải thông tin từ các cá thể NC và xảy ra trong tất cả các thiết kế NC hoặc thái độ khai thác thông tin
- Nó thường xảy ra trong các NC bệnh chứng, NC thuần tập hồi cứu đặc biệt có liên quan đến việc đánh giá tình trạng PN vì sự hiểu biết rõ về tình trạng bệnh có thể dẫn đến việc khai thác sai lệch tiền sử PN. Còn trong NC thuần tập tương lai ít xảy ra
- Loại sai số này cũng có thể làm sai lệch kết quả NC can thiệp, nhất là NC can thiệp không sử dụng placebo và kỹ thuật “mù” trong quan sát

***Sai số bỏ cuộc:**

- Sai số này chỉ xảy ra trong các NC thuần tập tương lai, nguồn gốc là do bỏ cuộc của đối tượng NC sau một thời gian dài hoặc ngắn đến khi xuất hiện hậu quả bệnh
- Sai số bỏ cuộc luôn luôn xảy ra chừng nào tỉ lệ bỏ cuộc có liên quan đến cả tình trạng PN và bệnh

***Sai số phân loại:**

- Xảy ra khi người NC phân loại nhầm lẫn hoặc về tình trạng PN hoặc về tình trạng bệnh của những người tham gia NC ở trong bất kỳ NC nào vì mức độ không chính xác cả trong việc báo cáo và thu thập thông tin là khó tránh khỏi
- Ảnh hưởng của sai số phân loại phụ thuộc vào sự xếp lẫn PN (hay bệnh) có độc lập với bệnh(hay PN) hay không
- Sai số phân loại ngẫu nhiên thường làm loãng bất kỳ một kết hợp thật nào giữa PN và bệnh
- Sai số phân loại ngẫu nhiên sẽ trở thành nghiêm trọng khi phân loại khác nhau giữa các nhóm, xảy ra khi tỉ lệ người bị xếp lẫn khác nhau trong hai nhóm của NC

Câu 8: Cơ chế truyền nhiễm và phân loại bệnh truyền nhiễm:

1. **Cơ chế truyền nhiễm:** Là 1 cơ chế đảm bảo cho vi sinh vật(VSV) gây bệnh từ vật chủ này sang sinh trưởng và phát triển ở 1 vật chủ khác. Cơ chế truyền nhiễm gồm 3 giai đoạn:

- VSV gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ
- VSV gây bệnh tồn tại ở môi trường bên ngoài
- VSV gây bệnh xâm nhập vào vật chủ mới

1.1. VSV gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ:

- Vị trí cảm nhiễm thứ nhất quyết định con đường giải phóng VSV gây bệnh ra khỏi cơ thể

Ví dụ:

- VSV gây bệnh có vị trí cảm nhiễm ở ruột, theo phân ra ngoài. Ví dụ vi khuẩn tả, lỵ...
- VSV gây bệnh có vị trí cảm nhiễm ở niêm mạc đường hô hấp theo nước bọt bắn ra ngoài khi ho hoặc hắt hơi. Ví dụ: vi khuẩn bạch hầu
- Các bệnh truyền nhiễm chỉ có 4 vị trí đào thải khỏi cơ thể:
 - Theo phân
 - Theo đờm và các chất tiết ở mũi họng
 - Theo máu được các vec tơ trung gian hút ra khỏi cơ thể
 - Theo sự thải bỏ của da, niêm mạc, lông, tóc

1.2. VSV gây bệnh tồn tại ở môi trường bên ngoài:

- Các VSV gây bệnh có thể tồn tại ở: đất, nước nếu thải theo phân.
- Thời gian tồn tại ở môi trường bên ngoài lâu hay ngắn tùy thuộc vào điều kiện của môi trường ngoại cảnh, nhưng quyết định vẫn là sức đề kháng của VSV gây bệnh
- Nếu vi sinh vật gây bệnh được giải phóng từ đường hô hấp thì chúng sẽ vào không khí

- Thời gian tồn tại ở môi trường bên ngoài lâu hay chóng tùy thuộc vào điều kiện của môi trường ngoại cảnh, nhưng quyết định vẫn là sức đề kháng của vi sinh vật gây bệnh

VD: Triclarin tồn tại rất lâu ở môi trường ngoại cảnh, virus viêm gan và trực khuẩn thương hàn có sức chịu đựng khá cao ở ngoại cảnh, các loại không có sức chịu đựng lâu ở ngoại cảnh như virus sởi, dại...

1.3. VSV gây bệnh xâm nhập vào vật chủ mới:

- Về cơ bản đường vào vật chủ mới của VSV giống như đường mà VSV đã sử dụng để thoát ra khỏi vật chủ cũ
- Các bệnh đường hô hấp thì đường hô hấp vừa là đường vào vừa là đường ra của VSV gây bệnh. Ví dụ vi khuẩn viêm màng não từ niêm mạc mũi họng ra ngoài thì cũng qua đó vào cơ thể. Như vậy lối vào cơ thể vật chủ của vi sinh vật gây bệnh cũng do vị trí cảm nhiễm thứ nhất của chúng trong cơ thể quyết định
- Một số VSV gây bệnh phải do môi giới truyền. VD: ký sinh trùng sốt rét do muỗi Anopheles truyền
- Tóm lại, bệnh nhiễm khuẩn nào cũng cần phát hiện vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh và cơ chế truyền nhiễm của bệnh đó

2. Phân loại bệnh truyền nhiễm:

Căn cứ vào vị trí cảm nhiễm thứ nhất của VSV gây bệnh và cơ chế truyền nhiễm. Các bệnh truyền nhiễm có thể chia làm 4 nhóm chính:

- Bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa
- Bệnh truyền nhiễm đường hô hấp
- Bệnh truyền nhiễm đường máu
- Bệnh truyền nhiễm đường da và niêm mạc

Câu 9.Trình bày phương thức lây nhiễm chủ yếu và biện pháp dự phòng HIV/AIDS

1.Phương thức lây nhiễm chủ yếu: qua 3 đường:

a.Qua máu và các chế phẩm máu: Châm sóc y tế, nhổ răng, ghép tạng, truyền máu, PN nghề nghiệp, qua đường tiêm chích không an toàn(dùng chung bơm kim tiêm)

b.Qua đường tình dục: Lây nhiễm cao trong quan hệ tình dục đồng giới không an toàn, liên quan chặt chẽ đến tình trạng nhiễm STIs

c.Qua đường lây truyền từ mẹ sang con: Lây truyền qua 3 giai đoạn: mang thai, chuyển dạ và sinh, cho con bú

2.Các biện pháp dự phòng HIV/AIDS:

a.Phòng lây HIV qua đường truyền máu:

- Giảm sử dụng máu toàn phần
- Sàng lọc người cho máu trước khi xét nghiệm
- Thực hiện vô trùng chăm sóc y tế

b.Phòng lây qua đường tiêm chích:

- Chương trình trao đổi bơm kim tiêm
- Chương trình cung cấp methadone
- Giảm sử dụng đường tiêm chích
- Tiệt trùng kim tiêm và dụng cụ tiêm chích

c.Phòng lây qua đường tình dục:

- Giảm số bạn tình
- Thực hành tình dục an toàn
- Triển khai chương trình cung cấp và hướng dẫn sử dụng BCS
- Triển khai chương trình điều trị các nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục
- Sử dụng màng ngăn có chất diệt tinh trùng
- Khuyến khích người nhiễm HIV đăng ký tham gia vào điều trị và duy trì điều trị để giảm tải lượng virus

d.Phòng lây truyền từ mẹ sang con:

- Các thai phụ cần được tư vấn về HIV ngay từ đầu thai kỳ
- Sàng lọc HIV hàng loạt cho thai phụ. Điều trị sớm cho thai phụ nhiễm HIV

Câu 10: Trình bày các yêu cầu và các giai đoạn tiến hành điều tra một vụ dịch

1. Các yêu cầu điều tra một vụ dịch:

***Các lý do cần phải tiến hành điều tra dịch:**

- Phòng chống lây lan dịch.
- Đề xuất các dịch vụ cần thiết.
- Nâng cao hiểu biết về lịch sử tự nhiên, bệnh cảnh lâm sàng và dịch tễ học về các vấn đề điều tra.
- Đẩy mạnh giám sát thông qua việc đánh giá chất lượng.
- Cung cấp các cơ hội cho đào tạo dịch tễ học thực địa.

***Người ta tiến hành điều tra vụ dịch trong các trường hợp sau:**

- Khi nhận được báo cáo về tăng các ca mắc bệnh nghi là dịch.
- Khi phân tích định kỳ các số liệu GSDT phát hiện có sự gia tăng tỷ lệ mới mắc, tăng số trường hợp tử vong một cách bất thường.
- Khi các thầy thuốc LS báo cho cơ quan y tế về sự xuất hiện bất thường của những trường hợp bệnh tại bệnh viện hay phòng khám.
- Khi cộng đồng phát hiện các trường hợp tử vong, mắc bệnh không đến khám ở cơ sở y tế.
- Có hiện tượng tử vong không rõ nguyên nhân hoặc NN bất thường.

2. Các giai đoạn tiến hành điều tra một vụ dịch:

2.1. Chuẩn bị điều tra:

- Thành lập nhóm điều tra
- Phân công trách nhiệm cho những người tham gia điều tra: nguồn lực nào do địa phương? Nguồn lực nào do nhóm điều tra cung cấp? ai trực tiếp điều tra? ai phát ngôn? ai phụ trách chính và giám sát cuộc điều tra? ai phân tích số liệu? ai viết báo cáo, báo cáo nộp cho ai?...
- Rà soát lại công tác chuẩn bị: chuẩn bị thủ tục hành chính; chuẩn bị vật dụng cần thiết; chuẩn bị phương tiện đi lại; chuẩn bị cộng đồng; xem lại y văn và tập hợp các tài liệu liên quan...

2.2. Các bước điều tra:

1. Xác định sự xuất hiện dịch
2. Khẳng định chẩn đoán
3. Xác định ca bệnh và tần số xuất hiện ca bệnh
4. Mô tả các ca bệnh theo thời gian, không gian và con người
5. Xác định người có nguy cơ cao mắc bệnh
6. Phát triển các giả thuyết về mối liên quan giữa PN với yếu tố nguy cơ và bệnh
7. So sánh các giả thuyết với các thông tin hiện có
8. Lập kế hoạch cho các NC tiếp theo
9. Viết báo cáo
10. Tiến hành các biện pháp phòng chống dịch.

Câu 11: Các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết

1. Nguyên tắc phòng chống:

- Chưa có vacxin phòng bệnh
- Không có thuốc điều trị đặc hiệu
- Phòng bệnh tốt nhất và quan trọng nhất là diệt muỗi, loăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt

2. Các biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm:

- Điều tra DTH xác định đối tượng, thời gian nơi có nguồn truyền nhiễm
- Chẩn đoán sớm tại cộng đồng và phòng thí nghiệm sớm
- Chăm sóc và điều trị tích cực bệnh nhân
- Người bị SXH cần nằm màn, tránh muỗi đốt để tránh lây lan

3. Các biện pháp với đường truyền nhiễm:

- Giám sát vec tơ truyền bệnh
- Diệt muỗi bọ gậy
- Chồng muỗi để trứng bằng dây kín các dụng cụ chứa nước
- Thau rửa dụng cụ chứa nước
- Thả cá diệt bọ gậy
- Thu gom các phế thải trong nhà, dọn vệ sinh môi trường

4. Các biện pháp đối với khối cảm nhiễm:

- Truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh muỗi đốt
- Tránh muỗi đốt bằng ngủ màn, mặc áo dài tay, bôi thuốc chống muỗi
- Diệt muỗi bằng hương trừ muỗi, máy hút muỗi, phun thuốc diệt muỗi

5. Biện pháp khác: Huy động cộng đồng tham gia phòng chống muỗi đốt, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sốt xuất huyết

Câu 12: Trình bày các biện pháp phòng chống bệnh tả

1. Biện pháp dự phòng:

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe
- Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Duy trì thường xuyên giá sát các trường hợp tiêu chảy cấp
- Luôn sẵn sàng có đội cơ động phòng chống dịch, chuẩn bị vật tư, hóa chất, thuốc, dịch truyền...
- Uống vắc xin sử dụng cho các đối tượng từ 2 tuổi trở lên
- Tổ chức YTTG khuyến nghị sử dụng trong những vùng có dịch lưu hành địa phương và nhóm nguy cơ cao

2. Các biện pháp chống dịch:

- Vụ dịch tả được xác định khi có ít nhất 1 ca bệnh tả được chẩn đoán bằng xét nghiệm
- Báo cáo khẩn cấp
- Công bố dịch
- Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, đội cơ động phòng chống dịch
- Xử lý ổ dịch

-Đối với bệnh nhân:.

- Cách ly, điều trị tại chỗ, tránh vận chuyển
- Khẩn trương bù nước, điện giải, kháng sinh đặc hiệu theo đúng phác đồ quy định
- Khử khuẩn, tẩy uế

-Đối với người tiếp xúc:

- Theo dõi ít nhất 5 ngày kể từ khi tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ lần cuối
 - Những người có nguy cơ cao như người sống cùng trong nhà, người trực tiếp chăm sóc, người ăn cùng nên được điều trị dự phòng càng sớm càng tốt
- ✓ Xử lý nguồn nước, đảm bảo vệ sinh ăn uống
 - ✓ Xử lý vệ sinh môi trường
 - ✓ Kiểm tra giá sát
 - ✓ Chấm dứt hoạt động khi không có người mắc trong 15 ngày, không tìm thấy vi khuẩn ở người tiếp xúc, nguồn nước uống, sinh hoạt, thực phẩm

Câu 13: Trình bày biện pháp phòng chống bệnh cúm mùa:

a. Dự phòng đặc hiệu:

- Vắc xin phòng bệnh định kỳ hàng năm
- Điều trị đặc hiệu

b. Dự phòng không đặc hiệu:

1. Quản lý người bệnh:

- Điều trị sớm bằng thuốc kháng vi rút trong các trường hợp nhiễm cúm có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ
- Cách ly ca bệnh ở nhà ít nhất trong vòng 24 giờ sau khi hết sốt để phòng lây bệnh cho người khác
- Đeo khẩu trang, che miệng mũi khi hắt hơi
- Sử dụng vật dụng riêng rẽ
- Để hạ sốt chỉ dùng paracetamol khi sốt trên 38 độ C
- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý (ăn thức ăn dễ tiêu và uống nhiều nước, ăn hoa quả, bổ sung các vitamin) và cân bằng nước điện giải

2. Vệ sinh và bảo vệ cá nhân chưa bị mắc bệnh:

- Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết
- Tránh tụ tập đông người khi đang có dịch
- Thường xuyên vệ sinh bàn tay bằng xà phòng
- Đeo khẩu trang khi đến chỗ đông người hoặc khi có tiếp xúc với người bệnh, người có nguy cơ cao
- Vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối
- Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời
- Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng

3. Vệ sinh môi trường:

- Tăng thông khí, hạn chế sử dụng điều hòa
- Lau bề mặt, đồ đạc bằng dung dịch sát khuẩn

4. Truyền thông GDCK:

- Cung cấp thông tin về đặc điểm và diễn biến của dịch cũng như thực hành phòng chống bệnh cúm tại gia đình cộng đồng
- Vệ sinh cá nhân, chế độ dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe
- Khi có bất biểu hiện sốt, hắt hơi, đau đầu... đến khám và điều trị kịp thời
- Tiêm vắc xin cúm để phòng bệnh...

Câu 14: Các loại vaccin và lịch tiêm chủng trong chương trình lịch tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam: bản chất, liều tiêm, đường dùng, bảo quản và lịch tiêm của từng loại.

1. BCG - Bản chất: VK lao sống giảm độc lực, dưới dạng đông khô - Liều tiêm :0,1ml - Đường dùng: tiêm trong da - Bảo quản: 2 - 8°C, dùng 4h sau khi pha hồi chỉnh - Lịch tiêm: sơ sinh 2. OPV: - Virus bại liệt sống giảm độc - Liều : 2 giọt - Đường dùng: uống - Bảo quản: 2-8°C - Lịch: đủ 2 th, đủ 3 th, đủ 4 th 3. Bạch hầu, ho gà, uốn ván (DPT) - Hỗn hợp giải độc tố BH, UV và VK ho gà chết - Liều tiêm: 0,5ml - Đường dùng: tiêm bắp sâu - Bảo quản: 2 - 8 °C. Nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt độ, không được để đông băng - Lịch tiêm: Đủ 2 th, 3 th, 4 th 4. Sởi: - Virus sởi sống giảm độc - Liều tiêm: 0,5 ml - Đường dùng: tiêm dưới da - Bảo quản: Ở 2 - 8 °C, nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt độ ; 6h sau pha hồi chỉnh - Lịch tiêm: Từ 9 - 11 th 5. Uốn ván: - Bản chất: Giải độc tố - Liều tiêm: 0,5ml - Bảo quản: Ở 2 - 8 °C không làm đông băng vaccin - Đường dùng: tiêm bắp - Lịch tiêm: trong độ tuổi sinh đẻ, mang thai	7. Viêm não Nhật Bản: - Bản chất: virus viêm não nhật bản bất hoạt - Liều tiêm: 1-3 tuổi: 0,5 ml; 4-5 tuổi: 1ml - Đường dùng: tiêm dưới da - Bảo quản: 2 - 8 °C, nhạy cảm với ánh sáng nhiệt độ, không được để đông băng - Lịch tiêm: >12 tháng, liều 2 cách liều 1: 7-14 ngày; Liều 3 cách liều 2: 1 năm 8. Quinvaxem: - Bản chất: phối hợp bạch hầu - ho gà - uốn ván - VGB – HiB - Liều tiêm: 0,5 ml - Đường dùng: tiêm bắp - Bảo quản: 2 - 8 °C - Lịch tiêm: Đủ 2 th, 3 th, 4 th 9. Viêm gan B: - Bản chất: Tái tổ hợp - Liều tiêm: 0,5ml - Đường dùng: tiêm bắp - Bảo quản: 2 - 8 °C, không làm đông băng vắc xin - Lịch tiêm: sơ sinh, đủ 2 th, đủ 3 th, đủ 4 th. 10. Thương hàn - Bản chất: Vi khuẩn thương hàn bất hoạt - Liều tiêm: 0,5ml - Đường dùng: tiêm bắp - Bảo quản: 2 - 8 °C - Lịch tiêm: Từ 2 - 10 tuổi, tiêm 1 lần 11. Tả - Bản chất: Vi khuẩn tả bất hoạt - Liều : 1,5ml - Đường dùng: uống - Bảo quản: 2 - 8 °C - Lịch tiêm: Từ 2 - 5 tuổi. uống 2 lần, lần 2 cách lần 1 hai tuần
--	---

6. Hib: -Bản chất: Tái tổ hợp -Liều tiêm:0.5ml -Đường dùng: tiêm bắp -Bảo quản: 2 đến +8oC, nhạy cảm á/s, nhiệt độ , không được để đông băng -Lịch tiêm: Đủ 2, 3, 4 tháng tuổi	
--	--

II.Lịch tiêm chủng mở rộng:

STT	Đối tượng	Vacxin
1	Sơ sinh	BCG VGB mũi 0 (tiêm ngay sau sinh 24h)
2	Đủ 2 th	Quinvaxem mũi 1 (Bh-HG-UV-VgB-HiB) OPV lần 1 (<i>bại liệt uống</i>)
3	Đủ 3 th	Quinvaxem mũi 2 OPV lần 2
4	Đủ 4 th	Quinvaxem mũi 3 OPV lần 3
5	9 th	Sởi mũi 1
6	18 th	DPT mũi 4 (BH-HG-UV) Sởi mũi 2
7	1 đến 5 tuổi	VNNB lần 1 (<i>cho trẻ trên 1 tuổi</i>) lần 2 (<i>sau lần 1 từ 1 đến 2 tuần</i>) Lần 3 (<i>sau lần 2 một năm</i>)
8	2 đến 5 tuổi	Tả uống lần 1 (<i>trên 2 tuổi</i>) lần 2 (<i>sau lần 1 từ 1 đến 2 tuần</i>)
9	2 đến 10 tuổi	Thương hàn mũi duy nhất
10	Phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ	Tiêm càng sớm càng tốt khi có thai lần đầu or nữ 15 - 35 tuổi vùng nguy cơ mắc UVSS cao 1 th sau mũi 1 6 th sau mũi 2 hoặc trong thời kì có thai sau 1 năm sau mũi 3 hoặc trong thời kì có thai sau 1 năm sau mũi 4 hoặc trong thời kì có thai sau

Câu 15: Các biện pháp dự phòng bệnh tim mạch:

1. Dự phòng cấp 1:

- Giảm các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành
- Giảm hút thuốc lá
- Thay đổi chế độ ăn, giảm muối, giảm mỡ béo no, giảm calo
- Tăng vận động
- Điều trị tăng huyết áp

2. Dự phòng cấp 2:

- Chẩn đoán sớm khi mà có thể chữa khỏi được. Ví dụ: Phát hiện sớm tăng huyết áp giới hạn, điều trị kịp thời, làm cho huyết áp trở về bình thường
- Phòng sự xuất hiện bệnh: thay đổi yếu tố nguy cơ hay điều trị dự phòng không cho bệnh xảy ra.
- Phòng nhồi máu cơ tim, đột quỵ bằng thay đổi các yếu tố nguy cơ và điều trị dự phòng

3. Dự phòng cấp 3:

- Phòng biến chứng
- Thay đổi yếu tố nguy cơ hay điều trị ngăn không cho biến chứng xảy ra.

4. Cơ sở của các dự phòng chiến lược:

- Mức độ và chiều hướng. Tỷ lệ mới mắc và hiện mắc, DALY
- Tính sẵn có và khả thi của các biện pháp dự phòng
- Tính giá thành hiệu quả của các can thiệp
- Dự báo chiều hướng của các bệnh tim mạch trong tương lai
- Nhu cầu của bệnh nhân và cộng đồng
- Hiểu biết về nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ
- Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ
- Sự hợp tác của các chương trình, dự án

Câu 16: Trình bày biện pháp sàng lọc phát hiện sớm phát hiện một số bệnh ung thư: Ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến(chỉ học K vú và K CTC):

1.Ung thư vú:

- Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, có khả năng chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nếu phát hiện ở giai đoạn càng sớm tỷ lệ chữa khỏi càng cao.
- Các biện pháp để phát hiện sớm bao gồm: tự khám vú, chụp vú và khám vú chuyên khoa

a.Tự khám vú:

Được khuyến cáo hàng tháng sau sạch kinh 7-10 ngày đối với phụ nữ ngoài 20 tuổi. Cởi bỏ áo trước khi khám, nơi khám là phòng ngủ, nhà tắm đủ ánh sáng, ngồi hoặc đứng khám miễn là thoải mái

- **Quan sát vú:** trước hết cần đưa tay ra sau gáy hoặc xuôi tay sau đó quan sát có dày lên, tụt núm vú, biến đổi màu sắc, tiết dịch... sau đó chống tay lên hông làm cử động cơ ngực lên xuống bằng cách nâng, hạ vai, nếu có sẽ rõ hơn
- **Sờ nắn vú:** nguyên tắc sờ nắn vú lành trước. Khi khám vú bên nào thì đưa tay cùng bên ra sau gáy, tay còn lại sờ nắn, 3 ngón tay áp sát vào nhau thành mặt phẳng ép đều lên các vùng khác nhau của tuyến vú vào thành ngực theo hướng xoắn ốc từ núm vú ngoài, sau đó khám hạch ở vùng hố nách. Khám tương tự đối với vú còn lại. Nếu thấy khối u, hạch, mảng cứng thì đến chuyên khoa khám lại

b.Chụp Xq vú:

- Chụp Xq vú có ưu thế rõ rệt là có thể phát hiện các tổn thương bất thường ở tuyến vú ngay cả khi trên LS chưa sờ thấy khối u
- Chụp Xq vú hàng năm khuyến cáo cho phụ nữ trên 40t, nếu có TS gia đình bị ung thư vú thì nên chụp bắt đầu kiểm tra từ 30t
- Chụp Xq vú không thay thế được khám vú và ngược lại

c. Khám vú tại cơ sở y tế chuyên khoa:

- Để khám vú đầu tiên là phải tìm hiểu cẩn thận về bệnh sử
- Ngoài các triệu chứng hiện tại cần biết thông tin về kinh nguyệt, tiền sử gia đình, dùng thuốc tránh thai, số lần sinh
- Phụ nữ trên 40 tuổi trở lên nên đến cơ sở chuyên khoa khám vú mỗi năm một lần

2.Ung thư cổ tử cung(CTC):

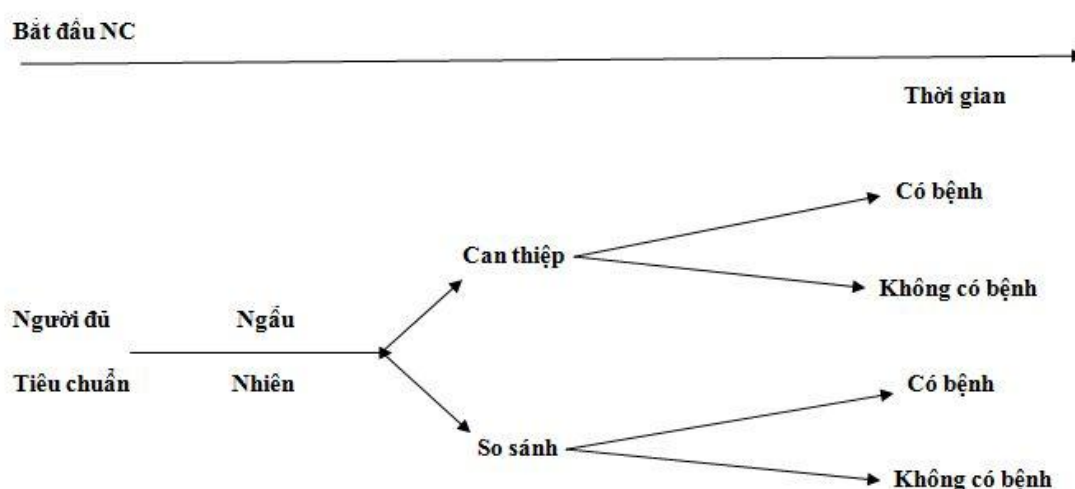
- Ung thư cổ tử cung là ung thư phổ biến thứ 2 sau ung thư vú ở nữ giới tại Việt Nam
- Khả năng chữa khỏi ung thư cổ tử cung càng cao nếu được phát hiện ở giai đoạn càng sớm và được điều trị kịp thời
- Phương pháp tế bào học âm đạo (PAP test) đến nay vẫn là phương pháp sàng lọc ung thư cổ tử cung hữu hiệu nhất
- Cách làm: dùng dụng cụ chuyên dụng quét vào CTC sau đó phết lên lam kính, nhuộm và xem tế bào qua kính hiển vi. Khuyến cáo làm PAP test kết hợp khám phụ khoa hàng năm ở độ tuổi sau 18 có quan hệ tình dục.
- Ngoài PAP test, soi CTC cũng là phương pháp hữu hiệu trong chẩn đoán sớm ung thư CTC.Soi CTC kết hợp với sinh thiết vùng nghi ngờ cho phép chẩn đoán được các tổn thương dạng tiền ung thư, qua đó BS chuyên khoa làm khoét chóp CTC để loại trừ nguy cơ phát triển thành ung thư CTC sau này. Bên cạnh đó làm xét nghiệm HPV CTC, nếu kết quả xét nghiệm HPV dương tính thì cần làm PAP test đều đặn hơn, sự có mặt HPV không có nghĩa là bị mắc ung thư CTC tuy nhiên sẽ làm tăng khả năng mắc bệnh.
- Ở Việt Nam, phụ nữ >30t có quan hệ sinh dục nên đi khám hàng năm, nếu có ra máu, dịch bất thường âm đạo cần tới khám kịp thời
- Tiêm vắc xin phòng nhiễm HPV gây ung thư CTC

Câu 17: Trình bày ĐNNC can thiệp, NC thực nghiệm và NC phỏng thực nghiệm và vẽ sơ đồ từng loại thiết kế NC:

1. NC can thiệp:

a. Định nghĩa: là một NC thực nghiệm có kế hoạch. Nó có thể được coi là một NC thuần tập tương lai vì các đối tượng NC được xác định dựa trên tình trạng PN, sau đó theo dõi sự phát triển bệnh hay một hậu quả nào đó. Khác với NC thuần tập, trong NC can thiệp, tình trạng PN của các đối tượng NC là do người NC chỉ định một cách ngẫu nhiên

b. Sơ đồ thiết kế NC can thiệp:



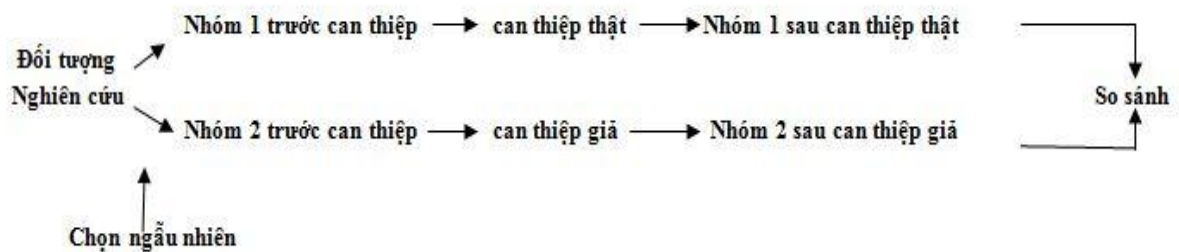
2. NC thực nghiệm:

a. Định nghĩa: Là thiết kế NC duy nhất có thể chứng minh được quan hệ nhân quả trên thực tế. có 3 đặc tính:

- Người NC tiến hành một can thiệp nào đó đối với một nhóm các đối tượng trong NC
- Có nhóm chứng, một hay nhiều nhóm đối chứng được chọn để so sánh với nhóm thực nghiệm
- Chọn ngẫu nhiên. Người NC quan tâm đến việc làm sao để phân bổ một cách ngẫu nhiên các đối tượng NC vào nhóm chứng và nhóm thực nghiệm.

*Vì lý do đạo đức, việc áp dụng NC thực nghiệm trên đối tượng con người thường bị giới hạn, tuy nhiên người ta đã sử dụng rộng rãi thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng đối với các loại thuốc mới

b. Sơ đồ NC thực nghiệm:

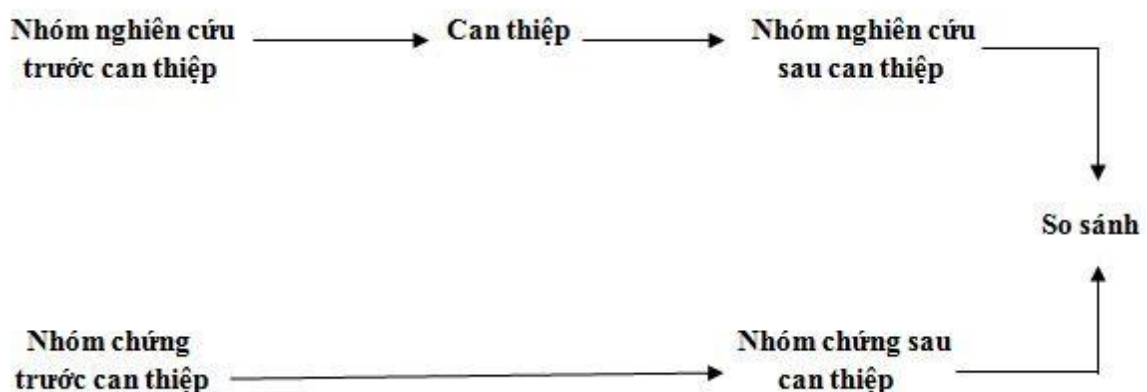


3. NC phỏng thực nghiệm:

a. Định nghĩa:

- Tại cộng đồng, nơi thường tiến hành các NC sức khỏe cộng đồng, chúng ta sẽ đối mặt với không chỉ các khía cạnh đạo đức mà còn cả khía cạnh thực hành trong khi triển khai các NC thực nghiệm. Trong điều kiện sinh hoạt thực tế, thường không thể chỉ định được các đối tượng vào một trong hai nhóm NC một cách ngẫu nhiên, đồng thời cũng rất khó duy trì nhóm chứng. Vì vậy các thiết kế NC thực nghiệm thường phải thay bằng các NC phỏng thực nghiệm hay giả thực nghiệm
- Trong NC phỏng thực nghiệm, ít nhất một đặc tính của NC thực nghiệm kinh điển sẽ bị mất đi: hoặc là không chọn ngẫu nhiên hoặc là việc không sử dụng một nhóm chứng riêng rẽ

b. Vẽ sơ đồ NC phỏng thực nghiệm:



Câu 18: Trình bày biện pháp y tế nhằm phòng chống các bệnh truyền nhiễm đối với nguồn truyền nhiễm

1. Biện pháp với nguồn truyền nhiễm là người:

A. Người bệnh:

A1. Chẩn đoán phát hiện sớm:

- Có 3 PP chẩn đoán bệnh truyền nhiễm: PP lâm sàng, PP xét nghiệm, PP điều tra dịch tễ.
- Sự quan trọng của 3 phương pháp trên tùy thuộc theo bệnh, ví dụ bệnh sởi chỉ cần chẩn đoán lâm sàng. Khi chẩn đoán phải căn cứ vào triệu chứng đặc hiệu tránh chẩn đoán sai.
- PP xét nghiệm: Đa số ít có tác dụng phát hiện bệnh sớm, ngoại trừ XN chẩn đoán sốt rét, sốt hồi quy. Điều này không làm giảm ý nghĩa của PP xét nghiệm vì đó là những PP chính xác
- PP dịch tễ: Căn cứ vào hỏi người bệnh và tài liệu về bệnh truyền nhiễm trong nhân dân ở vùng người bệnh sinh sống và vùng tiếp cận. Người bệnh có thể cho biết: đã tiếp xúc với người bệnh nào, đi đâu, dùng chung vật dụng với ai, nghề nghiệp... Các tài liệu điều tra dịch tễ thường giúp việc chẩn đoán đúng đắn, dù phương pháp này chỉ có ý nghĩa bổ trợ

A2. Khai báo hoặc thông báo quốc tế: phải thông báo đặc biệt các bệnh tả, sốt vàng, dịch hạch

A3. Cách ly:

- Cách ly người ốm có tác dụng ngăn ngừa bệnh lan truyền
- Đối với bệnh truyền nhiễm cấp tính việc cách ly cũng dễ dàng vì thời gian truyền nhiễm tương đối ngắn, nhưung khó khăn trong bệnh mạn tính
- Nguyên tắc cách ly phải có mức độ nhất định. Ví dụ người mắc lao chỉ cách ly ở bệnh viện trong thời kỳ bài tiết vi khuẩn
- Cách ly người bệnh sinh hoạt hàng ngày cũng là phương pháp tốt để ngăn VSV gây bệnh lan truyền
- Có xe riêng chở người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm
- Trong bệnh viện có buồng cách ly riêng cho từng bệnh nhân
- Thời gian cách ly tùy thuộc vào thời kỳ truyền nhiễm

A4. Khử trùng:

- Nhằm tiêu diệt VSV gây bệnh theo các chất tiết ra ngoài cơ thể bị nhiễm khuẩn bằng cách khử trùng các yếu tố bên ngoài bị ô nhiễm, với bệnh truyền nhiễm đều phải tẩy uế tức khắc
- Tẩy uế cuối cùng tiến hành sau khi người ốm được di chuyển đi khỏi ổ bệnh nhằm tiêu diệt VSV gây bệnh còn lại

A5. Điều trị đặc hiệu nhằm thanh toán trạng thái mang mầm bệnh, phải được thực hiện triệt để trong khi người ốm còn ở BV.

B. Người mang mầm bệnh:

- Những người khỏi bệnh(thương hàn...) phải có kế hoạch định kỳ xét nghiệm xem họ có trở thành người khỏi mang vi khuẩn không
- Bất cứ ai vào làm việc ở, cửa hàng thực phẩm, nhà máy nước, cơ quan giữ trẻ phải xét nghiệm có mang mầm bệnh đường ruột không, cần thêm khám định kỳ

2. Các biện pháp đối với nguồn truyền nhiễm là động vật:

Đối với gia súc, nếu sau khi khỏi bệnh mất giá trị kinh tế (trâu bò lở mồm long móng) thì giết đi. Nếu còn giá trị kinh tế (lao) thì cần chữa cho khỏi. Biện pháp chống dịch do cơ quan thú y tiến hành. Chó mặc đại: tiêu diệt, diệt chuột trong bệnh dịch hạch...

Câu 19.Trình bày các biện pháp y tế nhằm phòng chống các bệnh truyền nhiễm đối với đường truyền nhiễm

1.Bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa:

- Cơ chế lây truyền: phân-miệng.
- Yếu tố truyền nhiễm: nước, thực phẩm, ruồi, tay bẩn, đồ dùng.

1.1. Xử lý phân:

- Tránh phóng uế bừa bãi, nhất là gần nguồn nước uống và tắm rửa.
- Không dùng phân tươi dưới bất kỳ hình thức nào.
- Xử lý hố xí hai ngăn, ủ phân tại chỗ theo đúng quy cách.
- Chú ý giải quyết giải quyết phân xúc vật để góp phần giải quyết ruồi.

1.2. Cung cấp nước sạch:

- Không dùng nước bề mặt để ăn uống, tắm rửa. Dùng nước máy ở thành phố và nước giếng ở nông thôn.
- Kiểm tra vệ sinh các nhà máy nước.
- Chú ý chất lượng nước giếng bằng cách bảo quản giếng đất: đảm bảo chu vi bảo vệ.
- Giải quyết nước uống khi lao động xa nhà hoặc khi nắng to.
- Uống nước đã đun sôi.

1.3. Giải quyết rác: Tuyên truyền và đặt nê nếp thanh toán rác trong gia đình và nơi công cộng.

1.4. Vệ sinh thực phẩm: Kiểm tra các xí nghiệp sản xuất thực phẩm, cửa hàng thực phẩm...

e.Diệt ruồi:

- Diệt trừ ruồi bằng hóa chất và biện pháp dân gian hoặc cả 2
- Chủ yếu giải quyết phân và rác hợp vệ sinh
- Vận động ăn chín, uống sôi, rửa sạch tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, che đậy thức ăn.

2. Bệnh truyền nhiễm đường hô hấp:

- VSV gây bệnh ra ngoài theo các chất tiết của đường hô hấp
- Yếu tố truyền nhiễm là không khí, vật dụng. Phá hủy yếu tố truyền nhiễm này là rất khó khăn
- Khả năng tự làm sạch của không khí nhanh, do các hạt nhỏ lắng xuống và do đa số tác nhân gây bệnh không sống lâu được ở ngoại cảnh(sởi, cúm)
- Bệnh truyền nhiễm dễ dàng và nhanh chóng do bệnh nhân ho, hắt hơi
- Các biện pháp nhằm cắt đứt đường truyền nhiễm không hoàn thiện và không giữ vai trò chủ yếu: đeo khẩu trang có nhiều lớp gạc...

3. Bệnh truyền nhiễm đường, da niêm mạc:

- Có nhiều phương thức lây truyền khác nhau, do đó yếu tố truyền nhiễm cũng khác nhau. Ví dụ: Ghé lây qua quần áo, đau mắt hột qua khăn mặt, qua đất như uốn ván, xúc vật cắn như bệnh dại, tiếp xúc trực tiếp như lậu giang mai...
- Biện pháp quan trọng nhất là vệ sinh cá nhân, giáo dục sức khỏe, các biện pháp “xã hội” có vai trò quyết định trong một số trường hợp

-

4. Bệnh truyền nhiễm là đường máu:

4.1. Yếu tố truyền nhiễm là các động vật tiết túc hút máu như:

- Chấy rận truyền bệnh sốt phát ban, sốt hồi quy
- Các loại muỗi truyền bệnh sốt rét, viêm não nhật bản, sốt xuất huyết
- Bọ chét truyền bệnh dịch hạch
- Các loại ve truyền sốt phát ban địa phương

4.2.. Biện pháp diệt côn trùng truyền bệnh, cần nắm được sinh lý, sinh hóa của côn trùng. Phòng bệnh cơ học như lưới ở cửa sổ, xua đuổi bằng hóa chất.

Câu 20. Trình bày định nghĩa, mục tiêu và ứng dụng của giám sát DTH:

1. **Định nghĩa:** GSDTH là việc thu thập một cách hệ thống liên tục, về sự xuất hiện bệnh, phân tích, giải thích và phổ biến thông tin. Các tổ chức YTCC sử dụng dữ liệu giám sát để mô tả và theo dõi SK, xác định ưu tiên và giúp cho việc LKH, thực hiện, đánh giá những can thiệp và chương trình YTCC.

2. Mục tiêu và ứng dụng của giám sát:

2.1. Theo dõi những vấn đề sức khỏe:

- Sử dụng dữ liệu giám sát để phát hiện những tăng lên bất thường trong các trường hợp bệnh giúp tiến hành kịp thời các hoạt động chống dịch
- Theo dõi chiều hướng bệnh tật có thể dự báo mô hình xuất hiện bệnh trong tương lai, giúp ích cho việc lập kế hoạch những nguồn lực cần thiết
- Hiểu được mô hình xảy ra trong nhóm nguy cơ, giúp xác định đích và nhu cầu ưu tiên
- Theo dõi thay đổi tác nhân và yếu tố vật chủ để đánh giá khả năng tiềm tàng của việc xảy ra bệnh trong tương lai

2.2. Gắn với can thiệp y tế công cộng:

- Điều tra và khống chế: Khi có báo cáo về sự gia tăng những bệnh phải thông báo thì các cơ quan y tế cơ sở, tỉnh, quốc gia thậm chí quốc tế phải có những hoạt động kịp thời
- LKH: dựa vào sự thay đổi trong xuất hiện bệnh trong một thời gian dài trên một địa bàn, giúp dự đoán khi nào và ở đâu sẽ cần thiết các nguồn lực, giúp LKH phân bổ các nguồn lực một cách hợp lý
- Đánh giá những biện pháp phòng chống: sử dụng những dữ liệu giám sát để theo dõi và cải tiến những chương trình dự phòng
- Hình thành giả thuyết và khuyến khích NC YTCC: Việc thu thập và phân tích dữ liệu một cách liên tục nó có thể đưa ra những câu hỏi và những giả thuyết cung cấp hướng đi cho những NC sâu

2.3. Các ứng dụng khác của giám sát DTH:

- Thử nghiệm các giả thuyết: Những dữ liệu giám sát đôi khi có thể được sử dụng để thử nghiệm những giả thuyết liên quan tới tác động của PN lên sự xuất hiện bệnh
- Lưu trữ dữ liệu bệnh tật: Những dữ liệu lưu trữ có thể được sử dụng để phát triển những mô hình toán học dự báo tính bệnh tật, đánh giá ảnh hưởng của các chiến lược và chính sách can thiệp khác nhau.